

TEMA 2.1 • GINECOLOGÍA

Amenorrea

PERFIL EUNACOM 1.02.01

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Amenorrea

Definición

- **Primaria:** nunca ha menstruado y tiene ≥ 16 años (o ≥ 14 sin caracteres sexuales secundarios)
- **Secundaria:** ausencia de menstruación > 3 meses en mujer que antes menstruaba

Primer paso siempre: descartar embarazo

$> \beta$ -hCG antes de cualquier otro estudio

Amenorrea Primaria

Causas y evaluación

- Examinar caracteres sexuales secundarios (mamas, vello) y genitales
- Si **no hay útero** $\rightarrow$ pensar en **Síndrome de Mayer-Rokitansky** (agenesia vaginal/uterina, cariotipo 46XX) o **Síndrome de Morris** (resistencia a andrógenos, cariotipo 46XY, fenotipo femenino)
- Si **hay útero pero no menarquia** $\rightarrow$ evaluar nivel del bloqueo (ver algoritmo secundaria)

Amenorrea Secundaria

Algoritmo por FSH y LH

TABLA 2.1.1: FSH/LH VS ESTRÓGENOS		
FSH/LH	ESTRÓGENOS	DIAGNÓSTICO
$\uparrow\uparrow$	$\downarrow$	Falla ovárica primaria (menopausia precoz, Sx Turner)
Normal o $\downarrow$	Normal o $\downarrow$	Causa hipotalámica o hipofisaria

Causas hipotalámicas frecuentes

- Estrés, anorexia, ejercicio excesivo $\rightarrow \downarrow$ GnRH
- **Síndrome de ovario poliquístico (SOP/PCOS):** la más frecuente de amenorrea secundaria; TSH normal; $\uparrow$ LH / FSH normal $\rightarrow \uparrow$ andrógenos $\rightarrow$ oligomenorrea/amenorrea + acné + hirsutismo

Causas hipofisarias

- **Prolactinoma** ($\uparrow$ prolactina $\rightarrow$ inhibición de GnRH) $\rightarrow$ galactorrea + amenorrea - **Síndrome de Sheehan** (infarto hipofisario post-parto)

Causas uterinas

- **Síndrome de Asherman:** sinequias uterinas post-legrado o endometritis $\rightarrow$ amenorrea secundaria estructural

Resumen de Diagnóstico diferencial

TABLA 2.1.2: CAUSA VS CLÍNICA DIFERENCIADORA		
CAUSA	CLÍNICA DIFERENCIADORA	EXAMEN CLAVE
SOP	Irregular + androgenismo	Ecografía (ovarios poliquísticos) + LH/FSH
Prolactinoma	Galactorrea + $\uparrow$ prolactina	Prolactina + RNM hipofisaria
Sheehan	Post-hemorragia puerperal	Perfil hormonal completo
Falla ovárica	$\uparrow$ FSH + signos de menopausia	FSH

| Asherman | Post-legrado | Histeroscopia |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 28 años consulta por ausencia de regla por 5 meses. Refiere antecedente de legrado uterino hace 7 meses por aborto retenido. Al estudio: β -HCG negativa, estradiol, progesterona, FSH, LH, prolactina y TSH en rango normal, AMH normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Amenorrea. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Amenorrea secundaria: ausencia de menstruación por más de 3 ciclos o más de 90 días en ciclos irregulares.
- Siempre descartar embarazo como primer paso (β -HCG) antes de cualquier otro estudio.
- Estradiol bajo = hipogonadismo. Gonadotropinas altas = causa ovárica; bajas = causa hipotalámica/hipofisaria.
- Falla ovárica antes de los 40 años = menopausia precoz; después de los 40 años = menopausia normal.
- Síndrome de Sheehan: panhipopituitarismo por infarto hipofisario en hemorragia puerperal grave.
- Síndrome de Asherman: sinequias uterinas post-legrado; exámenes hormonales normales; diagnóstico con ecografía transvaginal.
- Amenorrea primaria: diagnóstico a los 15 años con desarrollo puberal o a los 13 años sin él.
- La AMH (hormona antimülleriana) refleja reserva ovárica: alta en SOP, baja en falla ovárica.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMENORREA)

PREGUNTA 1

Mujer de 28 años consulta por ausencia de regla por 5 meses. Refiere antecedente de legrado uterino hace 7 meses por aborto retenido. Al estudio: β -HCG negativa, estradiol, progesterona, FSH, LH, prolactina y TSH en rango normal, AMH normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Síndrome de ovario poliquístico
- B) Síndrome de Sheehan
- C) Síndrome de Asherman
- D) Falla ovárica prematura
- E) Hiperprolactinemia

PREGUNTA 2

Paciente de 35 años consulta por 6 meses sin menstruación. Estudio: estradiol bajo, FSH elevada, LH elevada, prolactina y TSH normales, β -HCG negativa, AMH muy disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A) Menopausia fisiológica
- B) Hipogonadismo hipogonadotrópico
- C) Síndrome de Asherman
- D) Falla ovárica prematura
- E) Síndrome de ovario poliquístico

PREGUNTA 3

Mujer de 30 años, parto hace 8 meses con hemorragia grave que requirió transfusiones. Desde el parto no ha podido lactar y consulta por ausencia de regla, astenia y sensación de frío. Exámenes: TSH baja, prolactina baja, FSH y LH bajas, estradiol bajo. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A) Hipotiroidismo primario
- B) Síndrome de Asherman
- C) Síndrome de Sheehan
- D) Hiperprolactinemia por adenoma
- E) Falla ovárica prematura

RESUMEN: AMENORREA

La amenorrea secundaria se define como la ausencia de menstruación por más de tres ciclos o más de 90 días en ciclos irregulares. Sus causas se dividen en fisiológicas (embarazo, lactancia, menopausia) y patológicas, que incluyen causas hormonales y anatómicas. El estudio clásico seguía una secuencia de pruebas (progesterona $\rightarrow$ estrógeno+progesterona) para localizar el nivel de la falla, aunque hoy está obsoleto. El enfrentamiento moderno consiste en solicitar todos los exámenes en conjunto: estradiol y progesterona, FSH y LH, prolactina, TSH, β -HCG y hormona antimülleriana (AMH). La interpretación se basa principalmente en el nivel de estradiol. Estradiol bajo indica hipogonadismo; si las gonadotropinas están altas, es hipogonadismo hipergonadotrópico (falla ovárica); si están bajas, es hipogonadismo hipogonadotrópico (causa hipotalámica o hipofisiaria). Estradiol normal con progesterona baja apunta a anovulación (SOP). La menopausia precoz se define como falla ovárica antes de los 40 años. El síndrome de Sheehan es un panhipopituitarismo por infarto hipofisiario secundario a hemorragia puerperal. El síndrome de Asherman (sinequias uterinas) se presenta con exámenes hormonales normales y antecedente de legrado. La amenorrea primaria se diagnostica a los 15 años con desarrollo puberal o a los 13 años sin desarrollo puberal. Su causa más frecuente es la anovulación. La prueba de progesterona sigue vigente en este contexto. El cariotipo descarta síndrome de Turner. La ecografía transrectal estudia malformaciones del tracto de salida.